



MANEJO DO HIV NA APS

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VII



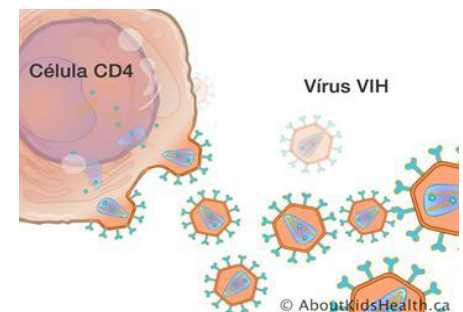
OBJETIVOS:

1. Compreender epidemiologia, avaliação, diagnóstico, acompanhamento e políticas públicas para a infecção por HIV.
2. Analisar o diagnóstico e acompanhamento da SIDA.
3. Identificar os determinantes de saúde e medidas preventivas ligados a essa patologia.

- O vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês *human immunodeficiency virus*) é um retrovírus da subfamília lentiviridae.
- O HIV infecta primariamente os linfócitos TCD₄ e macrófagos, onde se replica, levando a uma depleção lenta e gradual dos primeiros.
- As pessoas soronegativas têm, em média, 800 células/mm³ de sangue de LTCD₄.
- Nas pessoas soropositivas, a perda anual média de células de CD₄ é de 4%.



- No Brasil, o critério laboratorial para o diagnóstico de Aids é de $CD4 < 350$ céls/mm³.
 - ❑ A maior parte dos eventos definidores de doença ocorre quando $CD4 < 200$ céls/mm³.
- Entre a contaminação e a doença clínica ou laboratorial decorre o tempo de 5 a 10 anos.
- O vírus foi identificado em 1983, e em 1985 surgiu o teste sorológico para anticorpos anti-HIV.
- Em 1987, foram introduzidos os primeiros medicamentos antirretrovirais, mas somente em 1996 foi iniciada a terapia combinada com três ou mais medicações.



A crescente possibilidade de diagnóstico precoce, a simplificação dos esquemas medicamentosos em sua posologia e o controle de seus efeitos adversos vêm possibilitando aumento da expectativa de vida.

Os principais objetivos da abordagem inicial são: identificar o estágio clínico da infecção pelo HIV, avaliar a presença de coinfeções ou comorbidades, conhecer as vulnerabilidades socioculturais do usuário e estabelecer uma relação de confiança e respeito com a equipe multiprofissional do serviço de saúde, objetivando a pronta vinculação ao serviço de saúde.



TRANSMISSÃO VIRAL

- A forma mais comum de transmissão do HIV envolve a deposição do vírus nas superfícies mucosas, principalmente genital ou anal.
- A inoculação direta no sangue a partir de transfusões de sangue e hemocomponentes, a transmissão vertical, pelo leite materno e o uso compartilhado de seringas contaminadas também são formas comuns de transmissão do HIV, embora menos frequentes e em franca redução.
- A partir da transmissão viral, uma série de fatores determina o curso subsequente da infecção, incluindo o subtipo viral, o inóculo e as condições do indivíduo exposto.



Contacto sexual



Gravidez, nascimento e amamentação



Via sanguínea



Seringas e instrumentos infectados



Transfusão de sangue /órgãos

INFECÇÃO AGUDA

- Infecção primária ou síndrome da soroconversão.
- Acomete 50 a 90% dos que se contaminam e acontece entre 5 e 15 dias após a contaminação, durando em torno de 14 dias.
- Apresenta-se sintomática entre 25 e 60% dos casos.
- É raramente diagnosticada devido à sua inespecificidade e semelhança com outras doenças virais.
 - ❑ Febre, linfadenomegalia, faringite, exantema, mialgia/artralgia, diarreia, náuseas, vômitos e cefaleia.
- Nessa fase, a replicação viral é intensa e rápida, pois ainda não há resposta imunológica específica ao HIV. Há, também, queda transitória da contagem de linfócitos T-CD₄.

SOROCONVERSÃO

- Ocorre entre duas e três semanas após a infecção primária.
- A maior parte dos indivíduos passa a apresentar sorologia positiva para o HIV entre 4 e 10 semanas após a exposição.
- Ocorre em até seis meses para 95% dos indivíduos.



Fases da Infecção Pelo **HIV**





ANAMNESE

- Abordar questões relacionadas à sexualidade: início das relações sexuais, parcerias sexuais passadas e presentes, práticas sexuais, gestações pregressas e atuais, ISTs.
- Questionar sobre a existência de uso de drogas e álcool, fatores que aumentam a vulnerabilidade para a transmissão.
- Quando há história de uso de drogas injetáveis, deve-se questionar se houve compartilhamento de seringas e agulhas.
- Transfusões sanguíneas são importantes, principalmente se feitas há mais de 15 anos.
- Testes anti-HIV prévios devem ser questionados.

História médica atual e passada	Avaliar: • Presença de sinais e/ou sintomas • História de alergias, hipersensibilidade ou intolerância a medicamentos • História de tuberculose, prova tuberculínica ou IGRA (<i>interferon gamma release assay</i>), profilaxia e/ou tratamento prévio • História de doença mental familiar e/ou pessoal • Infecção oportunista (IO) prévia ou atual e necessidade de profilaxia para IO • Outras infecções ou comorbidades atuais e/ou pregressas, incluindo histórico de internações hospitalares • Histórico de imunizações • Uso de medicamentos, práticas complementares e/ou alternativas
Riscos e vulnerabilidades	Avaliar: • Parcerias e práticas sexuais • Utilização de preservativos e outros métodos de prevenção • História de sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) • Uso de tabaco, álcool e outras drogas • Interesse em reduzir os danos à saúde
História psicossocial	Avaliar: • Reação emocional ao diagnóstico • Rede de apoio social (família, amigos, organizações não governamentais, acesso a Rede de Atenção Psicossocial) • Nível educacional • Condições de trabalho, domicílio e alimentação
Saúde reprodutiva	Discutir/avaliar: • Desejo de ter filhos • Métodos contraceptivos • Estado sorológico da(s) parceria(s) e filho(s)
História familiar	Revisar histórico de: • Doenças cardiovasculares e hipertensão • Dislipidemias • Diabetes • Neoplasias



EXAME FÍSICO

- É necessário verificar e registrar peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC), bem como a circunferência abdominal.
- Uma ectoscopia completa pode ser realizada na busca de lesões de pele.
- A observação da cavidade oral pode revelar lesões, e a palpação de cadeias ganglionares deve ser realizada, como também a ausculta pulmonar.
- Fígado e baço serão palpados em busca de hepatoesplenomegalia.
- Exame da genitália poderá detectar sinais de infecção sexualmente transmissível (IST).
- O exame neurológico pode ser útil, se houver sintomas.

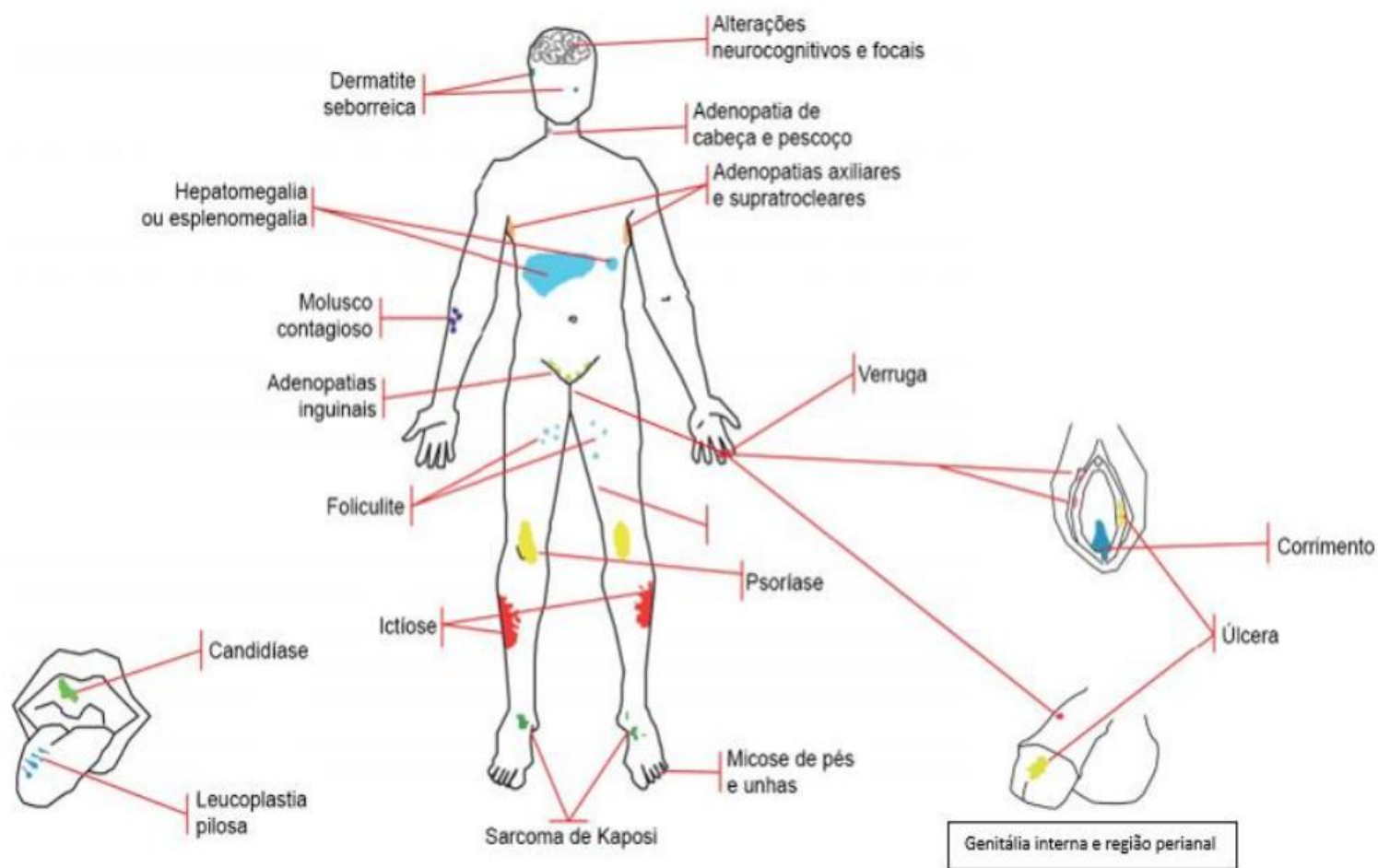


Figura 1: Sinais clínicos que podem estar relacionados à infecção pelo HIV e que devem ser investigados no exame físico inicial

Fonte: DATHI/SVSA/MS.

TESTE ANTI- HIV



- Ao solicitar o teste anti-HIV, deve-se levar em consideração o período chamado “janela imunológica”.
- Logo após a contaminação pelo HIV, ainda não existem anticorpos específicos em quantidade detectável pelos testes convencionais.
- Em 90% dos casos, estes se tornarão detectáveis em um período de 29 dias.
- O Ministério da Saúde (MS) recomenda que sejam aguardados 60 dias.

- A recomendação contida na Portaria no 59/GM/MS,34 de janeiro de 2003, é de que todas as amostras passem por dois imunoenaios denominados Elisa.
- Se os dois testes forem não reagentes, a amostra será considerada negativa para o HIV, e o exame será repetido apenas se houver suspeita de janela imunológica.
- Se houver um ou dois Elisa reagentes ou inconclusivos, a amostra será encaminhada para um segundo imunoensaio, que deve ser diferente do primeiro em sua metodologia para confirmação sorológica.

HIV Antibody Elisa Kit



- Atualmente, a indicação do MS é de priorizar os Testes Rápidos para o HIV, pois são de fácil execução e podem ser realizados em até 20 minutos.
- A sequência para os TRs é a seguinte:
 - ❑ Realizam-se dois diferentes testes em paralelo (Teste 1 e Teste 2); diante de dois testes positivos, considera-se a amostra positiva, bem como dois testes negativos consideram-na negativa; o Teste 3 será realizado se houverem resultados discordantes, definindo o resultado.
- A sensibilidade e a especificidade dos TRs se situam em percentuais próximos a 100%.



- Aspectos a serem abordados no aconselhamento pós-teste quando o resultado é negativo:
 - ❑ Discutir a possibilidade de janela imunológica e a necessidade ou não de nova testagem;
 - ❑ Lembrar que resultado negativo não significa imunidade;
 - ❑ Referenciar as práticas seguras.

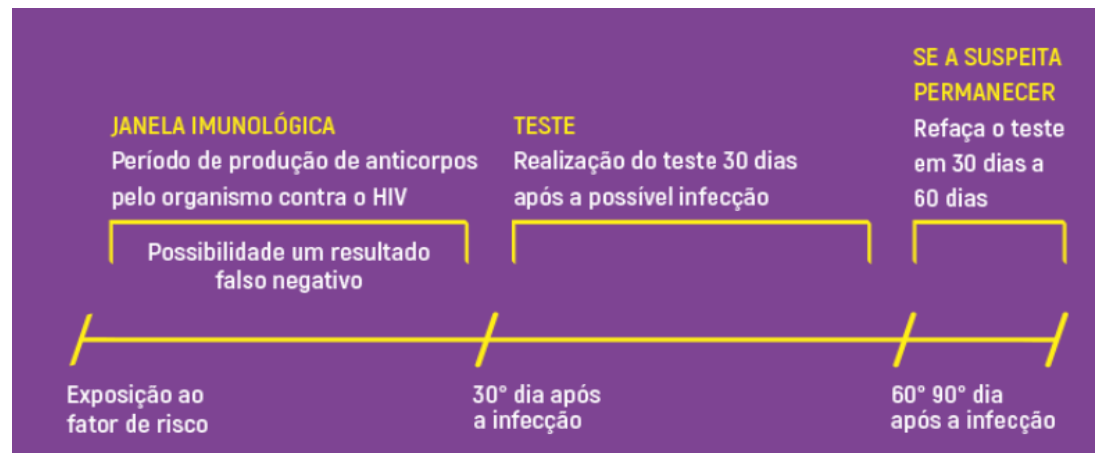


TABELA 141.2 → Indicações clínicas e epidemiológicas para testagem para o HIV

- Indivíduos apresentando DST
- Usuários de drogas
- Homens que fazem sexo com homens
- Indivíduos com tuberculose ativa
- Indivíduos que manifestam ter sido expostos a situação de risco
- Exposição a sangue e secreções corporais determinada por acidentes ocupacionais, ou outras exposições eventuais, como violência sexual
- Doadores de sangue, sêmen e órgãos
- Gestantes
- Parceiros sexuais de indivíduos caracterizados em qualquer uma das categorias acima

A testagem para o HIV também deve ser realizada como parte da avaliação das seguintes condições clínicas:

- Linfadenopatia generalizada
 - Demência não explicada
 - Meningite asséptica
 - Neuropatia periférica
 - Febre crônica não explicada
 - Diarreia persistente
 - Perda de peso não explicada
 - Herpes-zóster disseminado
 - Leucoplasia pilosa oral
 - Infecções oportunistas sugerindo imunidade celular depletada
 - Sarcoma de Kaposi
 - Linfoma de células B, especialmente se extranodal e de comportamento agressivo
 - Citopenias não explicadas
-

EXAMES COMPLEMENTARES

- A abordagem laboratorial no início do acompanhamento clínico auxilia a avaliação da condição geral de saúde, a pesquisa de comorbidades, a presença de coinfeções e a urgência no início da TARV.
- Também fornece informações laboratoriais basais pré-tratamento, bem como orienta sobre a necessidade de imunizações e profilaxias.



Avaliação laboratorial inicial

1. Hemograma
2. Glicemia de jejum
3. Colesterol total, frações e triglicerídeos
4. Teste tuberculínico (intradermorreação de Mantoux) – na ausência de tuberculose passada ou presente
5. Avaliação das funções hepática e renal
6. Contagem de linfócitos CD4
7. Quantificação da carga viral do HIV
8. Marcadores virais para hepatites A, B e C (anti-HAV, anti-HCV, HBsAg e anti-HBc)
9. Sorologia para toxoplasmose, citomegalovirose, doença de Chagas e infecção pelo HTLV-I e II
10. Sorologia para sífilis – testes não treponêmicos (VDRL ou RPR)
11. Exame qualitativo de urina
12. Exame parasitológico de fezes
13. Avaliação ginecológica e exame citológico de cérvix uterina
14. Radiografia de tórax

MANIFESTAÇÕES DE IMUNODEFICIÊNCIA AVANÇADA[†] (doenças definidoras de AIDS)

Síndrome consumptiva associada ao HIV (perda involuntária de mais de 10% do peso habitual) associada à diarreia crônica (dois ou mais episódios por dia com duração ≥ 1 mês) ou fadiga crônica e febre ≥ 1 mês

Pneumonia por *P. jirovecii*

Pneumonia bacteriana recorrente (dois ou mais episódios em um ano)

Herpes simples com úlceras mucocutâneas (>1 mês de duração) ou visceral em qualquer localização

Candidíase esofágica ou de traqueia, brônquios ou pulmões

Tuberculose extrapulmonar

Sarcoma de Kaposi

Doença por citomegalovírus (retinite ou outros órgãos, exceto fígado, baço ou linfonodos)

Neurotoxoplasmose

Encefalopatia pelo HIV

Criptococose extrapulmonar

Infecção disseminada por micobactérias não *M. tuberculosis*

Leucoencefalopatia multifocal progressiva

Criptosporidiose intestinal crônica (duração >1 mês)

Isosporíase intestinal crônica (duração >1 mês)

Micoses disseminadas (histoplasmose, coccidioidomicose)

Septicemia recorrente por *Salmonella* não *typhi*

Linfoma não Hodgkin de células B ou primário do sistema nervoso central

Carcinoma cervical invasivo

Reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e/ou miocardite)

Leishmaniose atípica disseminada

Nefropatia ou cardiomiopatia sintomática associada ao HIV



TRATAMENTO

- A recomendação da TARV para todas as PVHA, independentemente da contagem de LTCD₄, está associada com diversos benefícios tanto para o paciente, quanto para o sistema de saúde, quando atingidos os objetivos do tratamento:
 - ❑ Redução da morbimortalidade;
 - ❑ Aumento na expectativa de vida;
 - ❑ Redução da progressão da doença, evitando eventos definidores de Aids;
 - ❑ Redução de comorbidades (cardiovasculares, renais);
 - ❑ Redução na incidência de tuberculose;
 - ❑ Recuperação da função imune;
 - ❑ Supressão virológica duradoura;
 - ❑ Melhora na qualidade de vida;
 - ❑ Prevenção da transmissão.

- O esquema deve ser potente, com poucos efeitos adversos e com posologia confortável.
- Isso permite a melhor adesão, reduzindo a morbimortalidade e melhorando a qualidade de vida.

A TARV deve ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico

PVHA com carga viral indetectável têm risco zero de transmitir o HIV por via sexual.

Medicamentos	Apresentação	Posologia	Vantagens	Desvantagens
Zidovudina (AZT)	Comprimidos de 100 mg e de 300 mg (coformulado com 3TC)	300 mg, 2x/dia	Maior experiência, baixa toxicidade	Mielotoxicidade, lipoatrofia em longo prazo
Lamivudina (3TC)	Comprimidos de 150 mg coformulados ou não com AZT e TDF	150 mg, 2x/dia	Baixa toxicidade. Deve estar em todos os esquemas	
Tenofovir (TDF)	Comprimidos de 300 mg, pode ser coformulado só com entricitabina (FTC) com 3TC (3TC+EFZ)	300 mg/dia	Baixa toxicidade	Possível toxicidade renal. Solicitar Cr e calcular TFG. Se $< 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$, evitar o uso. Cautela em pessoas negras, com HAS e DM
Abacavir (ABC)	Comprimidos de 300 mg	300 mg, 2x/dia	–	Síndrome de hipersensibilidade. Solicitar o teste HLA-B 5701. Se positivo, não usar
Efavirenz (EFZ)	Cápsulas de 600 mg pode ser coformulado com 3TC+EFZ	600 mg/dia	Posologia, potência e meia-vida longa	Fenômenos neurológicos e possível toxicidade hepática

Nevirapina (NVP)	Comprimidos de 200 mg	200 mg, 2x/dia	Posologia, penetração na barreira placentária	Exantema que pode ser grave. Possível toxicidade hepática
Lopinavir/ritonavir Saindo de linha no Brasil	Cápsulas 133/33 mg	2 cápsulas, 2x/dia	Potência e durabilidade conhecidas	Dislipidemias, aumento do risco cardiovascular, diarreia
Darunavir (DRV)	Comprimidos de 400 mg	1 cp 2x/dia com 100	Potência e durabilidade	IP mais bem tolerado
		mg de ritonavir		
Raltegravir (RAL)	Comprimidos de 400 mg	1 cp 2x/dia		
Atazanavir (ATV)	Cápsulas 300 mg ou 200 mg	300 mg + 100 mg RTV ou 400 mg/dia	Não provoca dislipidemias	Hiperbilirrubinemia com ou sem icterícia
Doutegravir (DTG)	Comprimidos de 50 mg	1 cp por dia	Menos efeitos colaterais, alta potência e barreira biológica	Não pode ser usado com fenitoína, fenobarbital e oxycarbamazepina. Não deve ser usado com rifampicina

O esquema preferencial para início de tratamento é a associação de tenofovir com lamivudina e dolutegravir (TDF/3TC + DTG)

Quadro 4: Esquema de terapia antirretroviral inicial para adultos

Situação	Esquema antirretroviral
Esquema preferencial	Tenofovir ^a /lamivudina +dolutegravir
Intolerância ou contraindicação a dolutegravir	Substituir dolutegravir por darunavir + ritonavir ^b ou efavirenz ^c
Intolerância ou contraindicação a tenofovir ^d	Substituir tenofovir por abacavir ^e , se teste HLA-B*5701 negativo, ou por zidovudina



SEGUIMENTO

Exame	Seguimento	Observação
Hemograma	3-6 meses	Mais frequente se uso de medicações mielotóxicas
CD4	6 meses no primeiro ano	O PCDT indica que, se CV controlada e 2 medidas de CD4 > 350, não pedir
CV	6 meses após	Dois a três meses após início
	Anual	
Avaliação hepática e renal		Um mês após início do TDF para Cr, com cálculo de TFG
Escore de risco cardiovascular	Anual	Homens > 40 anos e mulheres > 50 anos sem RCV
PPD (teste de Mantoux)	Anual, se o inicial < 5 mm	
VDRL	6 meses	Se houver risco
Anti-HCV	Anual se o 1º for não reagente	Se houver risco
Perfil lipídico	Anual	Principalmente em uso de IP
Glicemia	Anual	Principalmente em uso de IP
Densitometria óssea	2-5 anos. Em mulheres pós-menopausa e homens > 50 anos	Principalmente se uso de TDF

FALHA TERAPÊUTICA

- Caracteriza-se como falha do tratamento antirretroviral a ausência de supressão viral após seis meses de TARV ou rebote da replicação viral após um período de supressão.
- As principais causas de falha são adesão incompleta, baixa potência do esquema, fatores farmacológicos que levem à má absorção, eliminação acelerada ou interações com outros fármacos que aumentem a metabolização da medicação.

COINFECÇÃO TUBERCULOSE/AIDS

- A infecção pelo HIV determina elevado risco de desenvolver tuberculose ativa e é cerca de 20 vezes superior em relação à população geral.
- A tuberculose é uma das manifestações mais frequentemente associadas à infecção pelo HIV e pode ocorrer com contagens de CD4 superiores a 200 células/mm³.
- É a principal causa conhecida de óbito por doenças infecciosas nas PVHA.
- O início do tratamento antirretroviral está indicado, independentemente da contagem de linfócitos T CD4 e da forma clínica de apresentação da tuberculose.

- A TARV deve ser começada no máximo até duas semanas após o início do tratamento para tuberculose em pacientes com $CD_4 < 200$ e até oito semanas para os demais.
- Não se recomenda o início concomitante do tratamento para os dois agravos.
- A rifampicina, um dos principais fármacos utilizados no tratamento da tuberculose, apresenta interação farmacológica importante com alguns antirretrovirais.
 - ❑ Essa interação determina redução dos níveis séricos dos antirretrovirais e consequente risco de surgimento de resistência.

PROGNÓSTICO

- Desde o advento da TARV altamente potente, o prognóstico para os soropositivos melhorou muito.
- Com adesão ótima ao tratamento, o controle da viremia pode ser completo, permitindo a recuperação imunológica e a consequente ausência de risco de adoecimento.
- Hoje, a expectativa de vida das PVHIVs, em tratamento e com CV controlada, não diferem mais da população geral.

ATIVIDADES PREVENTIVAS E EDUCAÇÃO

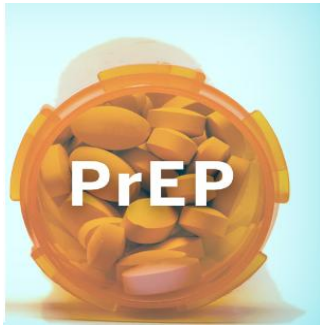
- A principal atividade preventiva é a de impedir e/ou minimizar a possibilidade de contaminação.
- Como a forma mais frequente de contaminação é a sexual, o uso de preservativos deve ser enfatizado, fornecendo-os sempre que possível.
- A educação sexual deve ser a mais precoce possível, respeitando a capacidade cognitiva para cada faixa etária.



- O uso de drogas injetáveis deve ser desaconselhado, e a pessoa ser encaminhada a tratamento quando concordar.
- ❑ Se não for possível interrompê-lo, orienta-se o não compartilhamento de seringas e, quando necessário, deve-se fornecê-las.
- Maior compreensão sobre HIV/Aids contribui para melhor adesão ao acompanhamento e tratamento, quando for necessário.
- Ante a ausência de eficácia de estratégias de vacinação contra o HIV, a utilização de medicamentos antirretrovirais como forma de prevenção da sua transmissão tem sido testada por meio de estratégias de profilaxia pré-exposição ou pós-exposição.

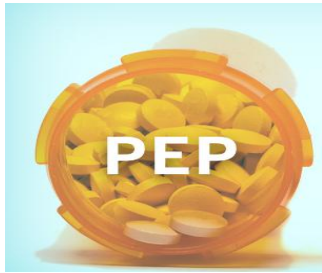
TABELA 141.6 → Vacinas recomendadas para indivíduos infectados com o HIV com idade acima de 13 anos

VACINA	RECOMENDAÇÃO
Tríplice viral	Uma ou duas doses nos suscetíveis com contagens de linfócitos CD4 inferiores a 200 células/mm ³ .
Varicela	Duas doses com intervalo de três meses nos suscetíveis com contagens de linfócitos CD4 inferiores 200 células/mm ³ . Contraindicada em gestantes.
Febre amarela	Individualizar o risco/benefício conforme a situação imunológica do paciente e a situação epidemiológica da região e, em caso de exposição, vacinar em situações em que há contagens de linfócitos CD4 inferiores a 200 células/mm ³ . Contraindicada em gestantes.
Dupla do tipo adulto (dT)	Três doses (0, 2, 4 meses) e reforço a cada 10 anos.
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)	Duas doses com intervalo de dois meses nos menores de 19 anos não vacinados.
Hepatite A	Duas doses (0 e 6 meses) em indivíduos suscetíveis à hepatite A (anti-HAV negativo), portadores de hepatopatia crônica, incluindo portadores crônicos do vírus da hepatite B e/ou C.
Hepatite B	Imunogenicidade e eficácia inferior em pacientes imunossuprimidos. Dose dobrada recomendada pelo fabricante, administrada em quatro doses (0, 1, 2 e 6 ou 12 meses) em todos os indivíduos suscetíveis à hepatite B (anti-HBc negativo, anti-HBs negativo).
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (23-valente)	Uma dose para indivíduos com contagens de linfócitos CD4 inferiores a 200 células/mm ³ . Apenas um reforço após cinco anos.
Influenza	Uma dose anual da vacina inativada contra o vírus influenza.



PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO

- A profilaxia pré-exposição (PrEP) com tenofovir e entricitabina tem sido indicada para HSH, homens e mulheres sexualmente ativos e usuários de drogas injetáveis com risco importante.
- Pode ser oferecida também para a pessoa soronegativa de casal sorodiscordante.
- A liberação da PrEP é recente no Brasil e tem sido realizada nos Centros de Testagem e Apoio-Serviços de Atenção Especializada (CTA-SAE).



PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO

Exposição ocupacional percutânea, mucosa ou pele não intacta :

- Deve-se procurar saber a condição sorológica da fonte;
- Se for desconhecida e possível, deve ser testada para estabelecer o risco real;
- Se o risco for considerado alto o suficiente, deve ser oferecida a profilaxia pós-exposição (PEP).
- No Brasil, o esquema de profilaxia é Tenofovir + Lamivudina + Atazanavir.
- Deve ser iniciada em até 72 horas e será usada por 28 dias.
 - ☐ Se a pessoa-fonte tiver resultado do teste anti- HIV negativo, deve ser suspensa.
- O profissional deve ser testado em 6, 12 semanas e 6 meses.

Exposição não ocupacional:

- São as situações inesperadas, como relações sexuais casuais sem proteção, estupro, compartilhamento de seringa no uso de drogas.
- Segue a mesma lógica da exposição ocupacional.

Dicas

- ▶ Pensar em teste anti-HIV sempre. A sua solicitação para o máximo de pessoas sexualmente ativas contribui para o diagnóstico precoce, reduzindo o adoecimento e a cadeia de transmissão.
- ▶ Nunca solicitar o teste sem fazer o aconselhamento prévio.
- ▶ No pré-natal, solicitar o teste no início e no terceiro trimestre. A contaminação durante a gestação aumenta muito o risco de transmissão vertical devido à sua alta CV.
- ▶ Ficar atento para a adesão e a adequação de rotinas.
- ▶ O uso de álcool, principalmente nos finais de semana, não deve levar à interrupção do uso da TARV.
- ▶ Não deixar de solicitar o teste anti-HIV por considerações pessoais a respeito de riscos. Lembre-se de que mulheres heterossexuais monogâmicas e pessoas idosas têm sido frequentemente diagnosticadas como soropositivas.
- ▶ Quando atender adolescentes, deve-se frisar que o uso de preservativos não deve ser interrompido com a estabilização da relação, a não ser que haja o conhecimento das sorologias do par e pacto de fidelidade ou de uso de preservativo nas relações extrapar.
- ▶ Não iniciar tratamento sem antes avaliar a compreensão da pessoa sobre a sua necessidade, bem como sua capacidade de adesão.
- ▶ Não considerar falha terapêutica sem antes avaliar criteriosamente a adesão e repetir a quantificação da CV.

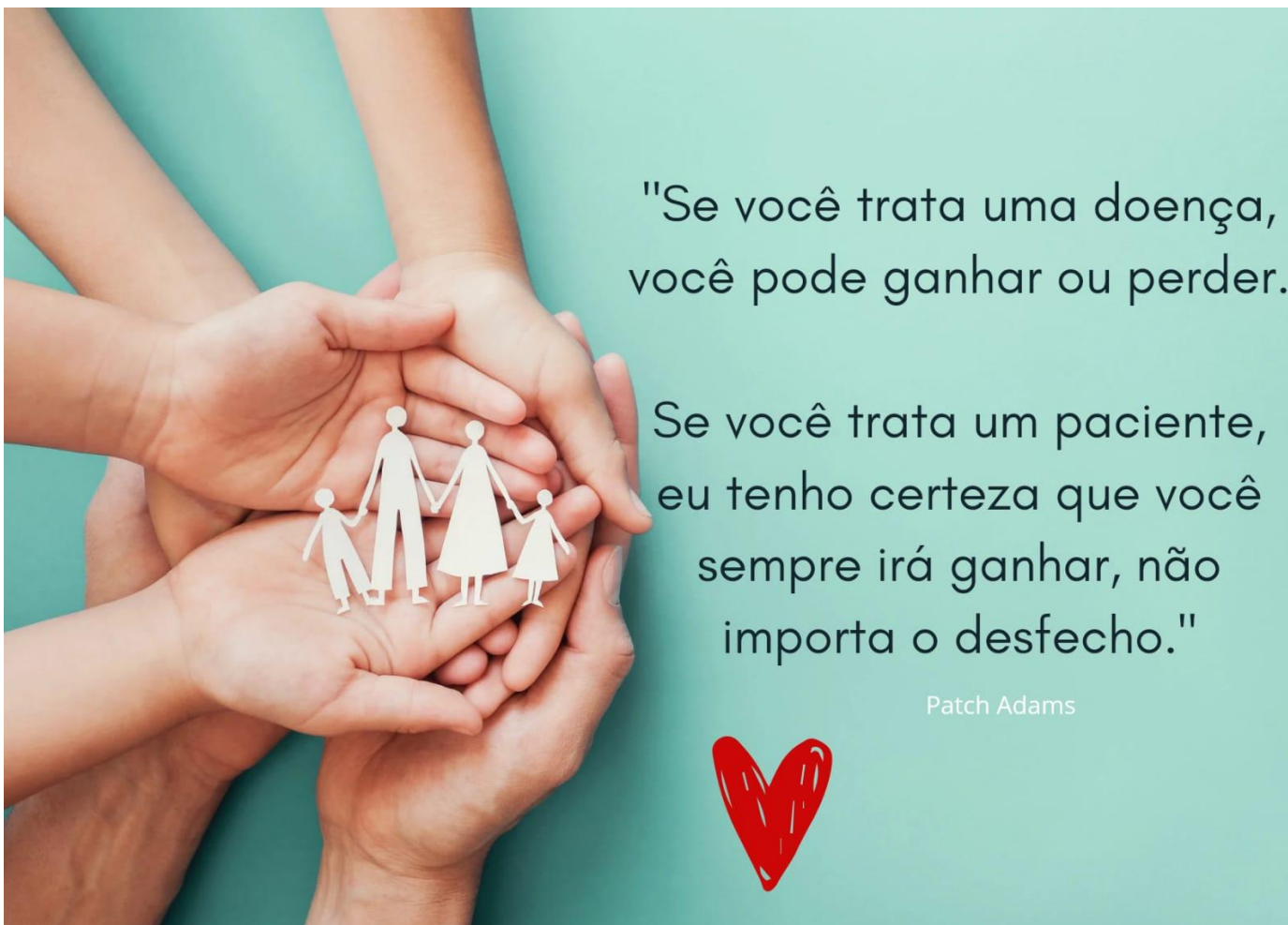
Referências Bibliográficas

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 141).

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_boas_praticas_hiv_aids_atencao_basica.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_integral_hiv_manual_multiprofissional.pdf

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/02120832-protocolo-dst-hiv-ses-rs-20160303_v018-lft.pdf



"Se você trata uma doença,
você pode ganhar ou perder.

Se você trata um paciente,
eu tenho certeza que você
sempre irá ganhar, não
importa o desfecho."

Patch Adams



Obrigada!